



ATIVIDADE TEÓRICO-PRÁTICA

Risco de suicídio

avaliação e conduta

Módulo E3M40

Funcionalidade III, Cognição e Humor



Prof. João Frederico Musial

Medicina | Campo Real | 2026



Antes de começarmos

O que vamos discutir

Esta aula trata de suicídio de forma direta, com falas de pacientes e com decisões clínicas reais. Não haverá imagem de método, de cena nem de lesão.

Você pode sair

Se em algum momento você precisar se afastar, saia da sala. Não é preciso justificar, e isso não será registrado de nenhuma forma. Voltar depois também está certo.

CVV 188, ligação gratuita, 24 horas

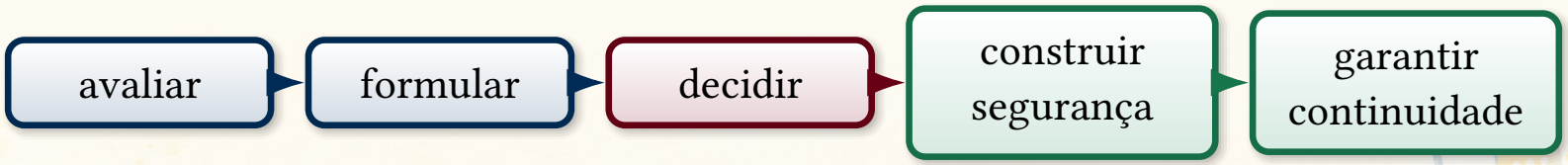
O apoio ao estudante do Campo Real está disponível depois da aula. O docente também está.

? A pergunta desta aula

É possível construir segurança suficiente fora de um ambiente protegido neste momento?

A tese

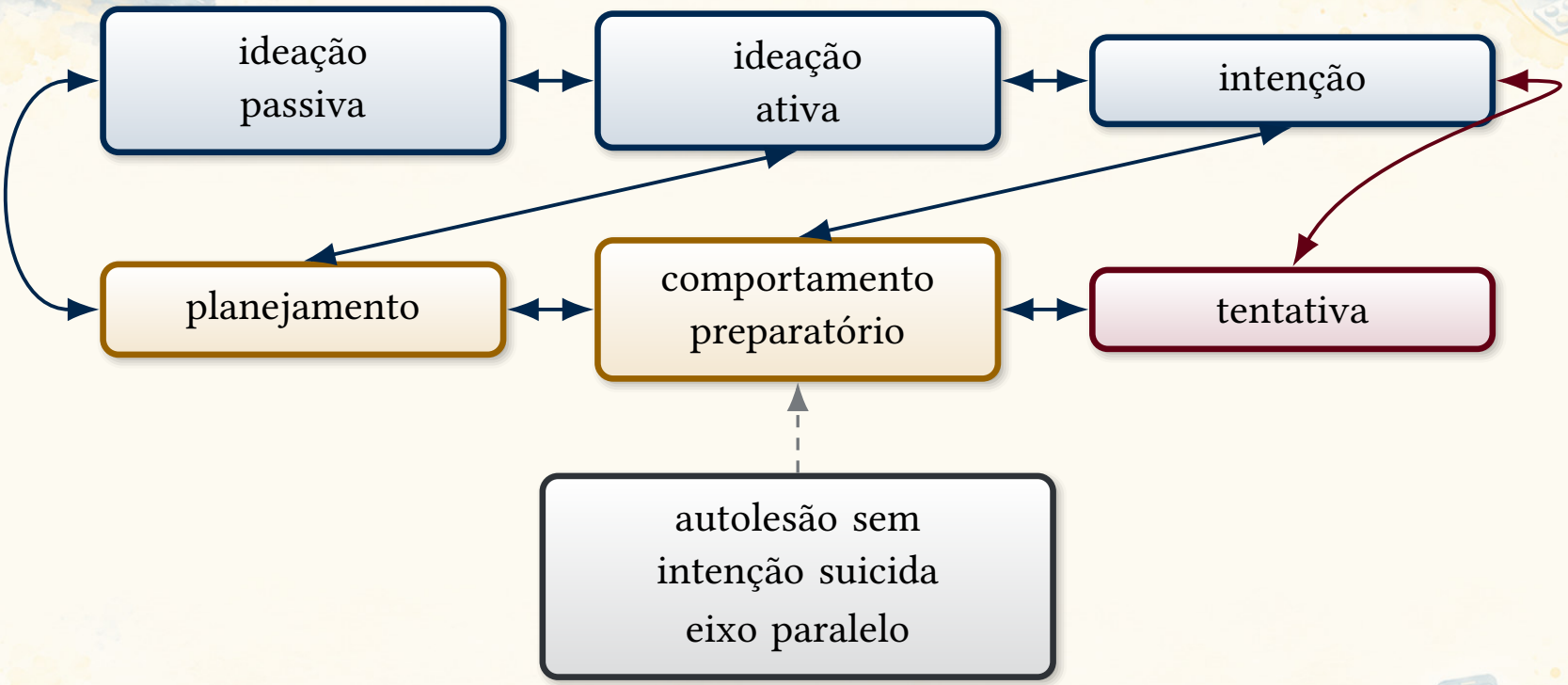
O risco suicida é **formulação clínica dinâmica**, construída pela interação entre vulnerabilidades basais e modificadores proximais, e não se reduz a escore nem a categoria. A conduta deve produzir **segurança agora** e **continuidade depois**.



Ao final: o que, neste paciente, muda o que você fará nos próximos 30 minutos?

O que estamos tentando entender

A preleção paralela do módulo cobre o diagnóstico do episódio depressivo; esta ATP cobre a conduta e trata a suicidalidade como fenômeno transdiagnóstico.



Esses fenômenos se relacionam nos dois sentidos. Não são uma escada obrigatória.

Duas leituras que atrapalham

A escada que não existe

Ninguém precisa passar por todos os degraus, na ordem, para chegar à tentativa. Uma parte das tentativas ocorre em quem nunca planejou, e uma parte de quem planeja durante anos nunca tenta.

Consequência: a ausência de um degrau anterior não tranquiliza.

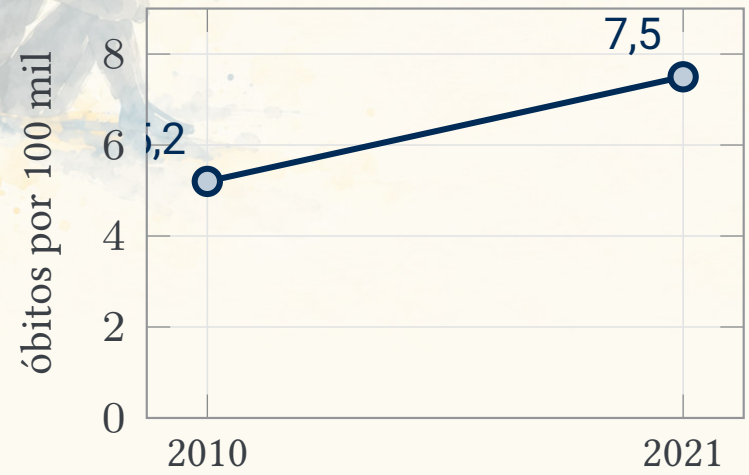
A autolesão no eixo ao lado

A autolesão sem intenção suicida tem função de regulação do sofrimento, e não de morte. Não é tentativa.

E ainda assim é um dos marcadores mais consistentes de risco futuro. As duas coisas são verdadeiras ao mesmo tempo.

Dizer *«ele só tem ideação passiva»* e encerrar aí é usar um degrau como se fosse um prognóstico.

Magnitude e tendência no Brasil



Dois pontos documentados. A série intermediária não foi reconstruída.

2021, no Brasil

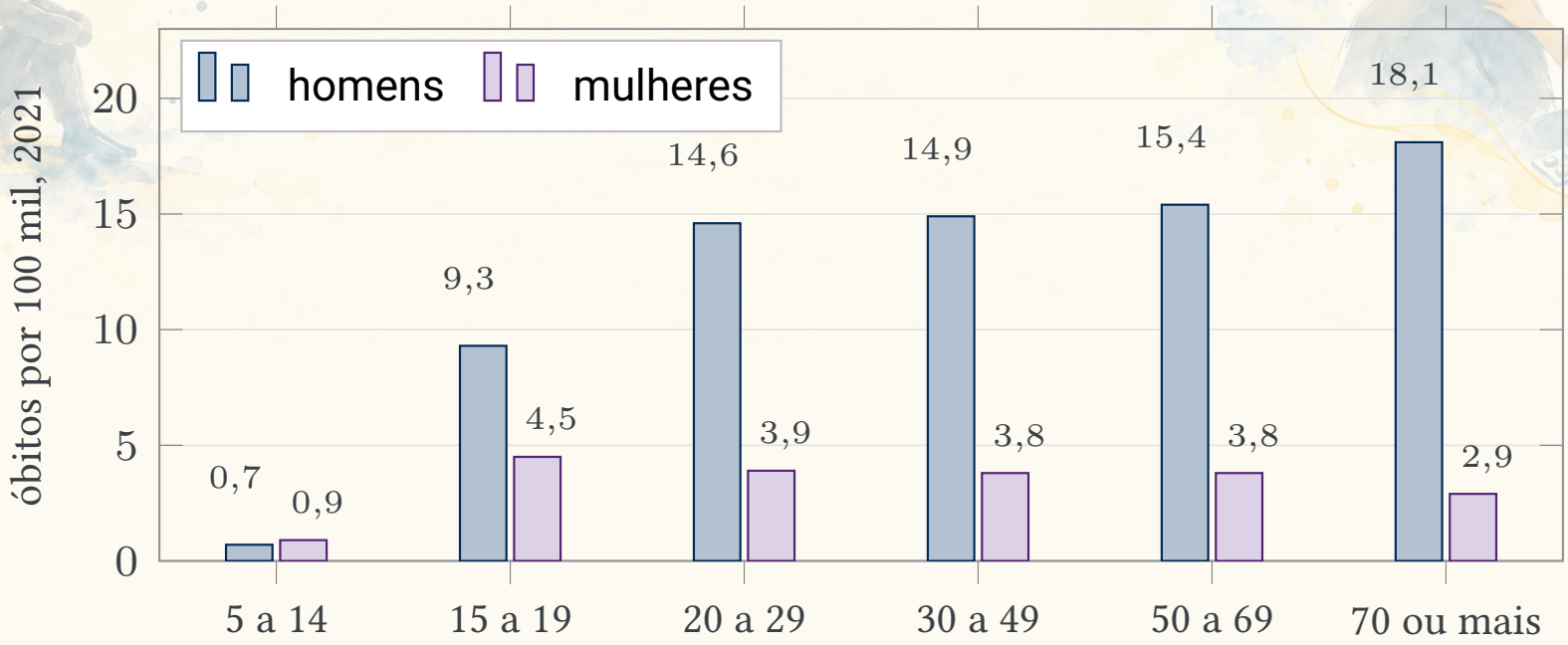
- **15.507** mortes por suicídio
- **114.159** notificações de lesão autoprovocada
- taxa de **7,5** por 100 mil, **42% acima** da taxa de 2010

O que essa razão diz

Para cada morte registrada há cerca de sete notificações de lesão autoprovocada. Essas pessoas passam pelo serviço.

Ministério da Saúde, Boletim Epidemiológico v. 55, n. 4, 2024, com dados do SIM e do SINAN.

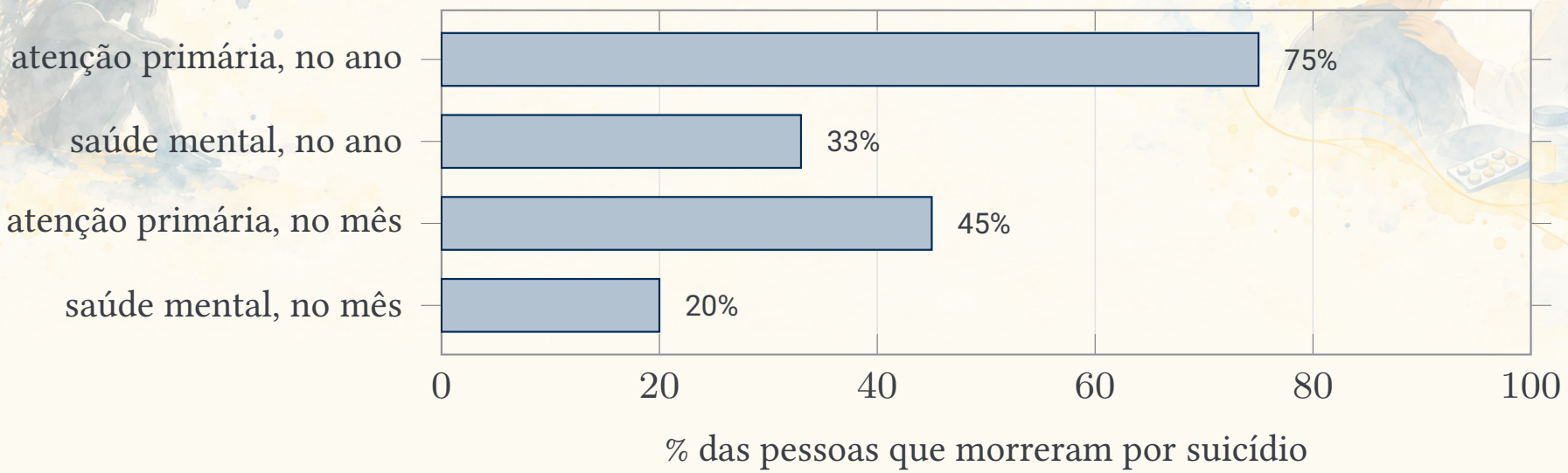
Quem morre, por faixa etária e sexo



A taxa mais alta está nos homens com 70 anos ou mais. É a faixa que o serviço menos pergunta.

Ministério da Saúde, Boletim Epidemiológico v. 55, n. 4, 2024.

Eles passam por nós antes



O que isso obriga

A pessoa que morre por suicídio costuma ter estado diante de um médico pouco antes, e quase sempre de um médico que não era psiquiatra. Em idosos, o contato com a atenção primária no mês anterior é ainda mais frequente do que em adultos jovens.

Luoma, Martin e Pearson, *Am J Psychiatry* 2002, revisão de 40 estudos. **[evidência]**

Perguntar não cria suicidalidade

O receio e a evidência

O receio de que perguntar sobre suicídio possa induzir a ideia é comum e não se sustenta. Revisão da literatura publicada não encontrou, em nenhum dos estudos revisados, aumento estatisticamente significativo de ideação suicida entre os participantes que foram perguntados.

O que perguntar produz

- nomeia o que o paciente não sabia como dizer
- mostra que o assunto cabe nesta consulta
- permite a pergunta seguinte

O que não perguntar produz

- um registro que diz apenas *«nega ideação»*
- uma alta que ninguém consegue justificar depois
- a impressão, no paciente, de que aquilo não se fala aqui

Dazzi, Gribble, Wessely e Fear, *Psychol Med* 2014, revisão em formato de editorial. **[evidência]**

Reconhecer a pista

Estas falas chegam ao pronto atendimento por outro motivo. Elas são a abertura, e não a queixa.

O que o paciente diz

- *«eu queria dormir e não acordar»*
- *«assim não dá mais»*
- *«eles ficariam melhor sem mim»*
- *«eu estou só cansado, doutor»*
- *«não sei quanto tempo eu aguento»*

O que a família diz

- *«ele deu as coisas dele»*
- *«ela ficou estranhamente calma»*
- *«ele se despediu de um jeito esquisito»*
- *«ela parou de atender o telefone»*
- *«ele acertou tudo o que estava pendente»*

Toda pista reconhecida obriga à pergunta seguinte. Reconhecer e não perguntar é pior do que não ter reconhecido.

A frase de transição

Esta é a frase. Não é exemplo do que dizer, é o que se diz.

> *«Pelo que você está me contando, esse sofrimento está bem pesado. Quando as pessoas chegam assim, às vezes pensam em morrer. Você tem tido esses pensamentos?»*

Por que funciona

Nomeia o sofrimento antes de perguntar, universaliza sem banalizar, e faz uma pergunta fechada que o paciente consegue responder com uma palavra.

O que não dizer

«Você não está pensando em fazer besteira, está?»

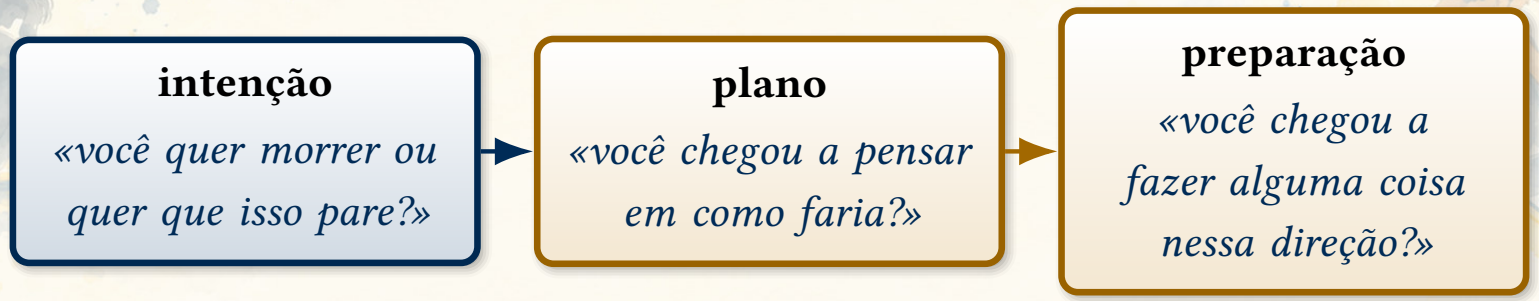
A pergunta já traz a resposta esperada.

Caracterizar a ideação

O que caracterizar	Como perguntar	O que muda
existe	*«você tem tido esses pensamentos?»*	abre ou fecha toda a sequência
frequência	*«quantas vezes, num dia como o de ontem?»*	separa o episódico do contínuo
duração	*«quando vem, fica quanto tempo?»*	minutos e horas pedem condutas diferentes
intrusividade	*«ele vem sozinho ou você o chama?»*	pensamento que invade cansa e desgasta
capacidade de afastar	*«quando vem, você consegue empurrar? o que ajuda?»*	é aqui que mora o plano de segurança

A última linha é a mais útil das cinco, e é a que quase ninguém pergunta.

Intenção, plano e preparação



A pergunta que falta

Depois de *«fez alguma coisa?»*, vem *«mesmo que depois você tenha desistido»*. É essa segunda metade que autoriza o paciente a contar o ato interrompido.

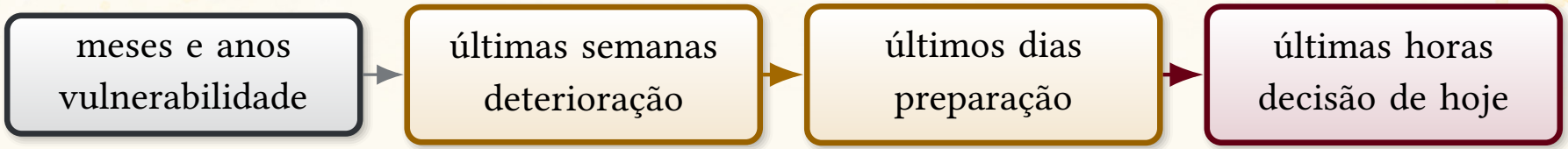
O que não entra na tela nem na pergunta

Não se pergunta detalhe de método por curiosidade clínica, e não se compara letalidade diante do paciente. O que importa é a existência do acesso e a possibilidade de restringi-lo.

Comportamento e temporalidade

A pergunta que organiza o tempo

«O que mudou nas últimas horas? E nos últimos dias?»



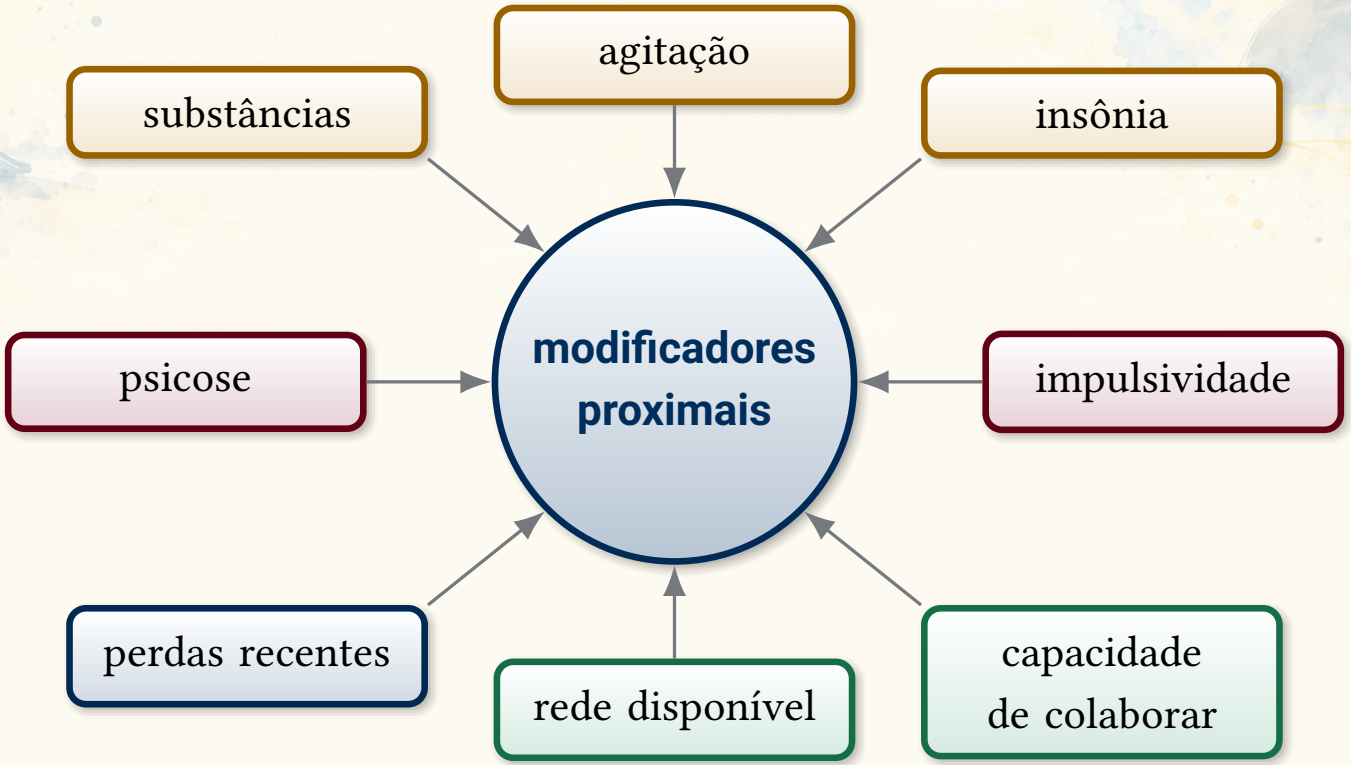
O que perguntar do comportamento

- o que fez, não só o que pensou
- o que interrompeu o ato, quando houve
- o que estava acontecendo naquela hora

Mudanças que pesam

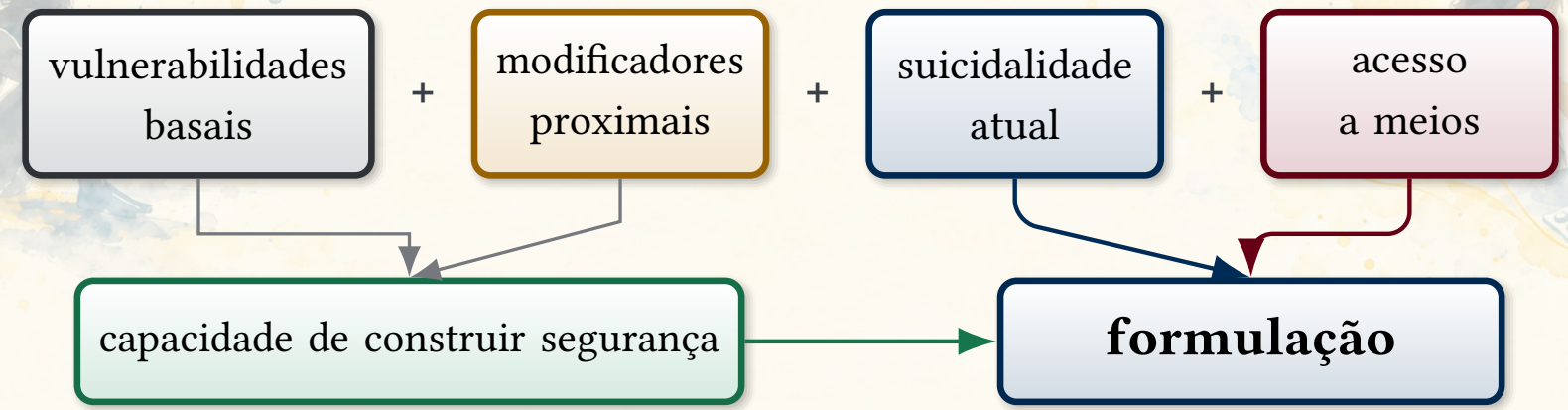
- sono que encurtou de repente
- retraimento que apertou nos últimos dias
- algo resolvido ou acertado sem explicação

O que modifica a segurança agora



Supervisão disponível e capacidade de colaborar são modificadores, e não detalhe de execução do plano.

A matriz da formulação



É possível construir segurança suficiente fora de um ambiente protegido neste momento?

A saída da matriz é uma pergunta que se responde com conduta, e não uma etiqueta.

Vulnerabilidades basais e modificadores proximais

Vulnerabilidades basais

O que este paciente carrega há meses ou anos.

- transtorno mental em curso
- tentativa prévia, o preditor isolado mais forte
- autolesão recorrente
- doença dolorosa ou incapacitante
- isolamento e perda de papel social

Modificadores proximais

O que está diferente nesta semana e nesta noite.

- intoxicação, agitação, insônia
- psicose e impulsividade
- perda, humilhação, ruptura recente
- mudança de tratamento ou alta recente
- rede que deixou de estar disponível

A vulnerabilidade explica por que este paciente, e não outro. O modificador explica por que hoje, e não no mês passado.

Suicidalidade atual e acesso a meios

Suicidalidade atual

O que foi caracterizado na entrevista, em vez de resumido em uma palavra: frequência, duração, intrusividade, capacidade de afastar, intenção, plano e preparação, com a data do que houve.

Acesso a meios

Três perguntas, e nenhuma sobre método:

- existe acesso agora?
- é concretamente possível restringir?
- quem da rede participa dessa restrição?

A pergunta sobre arma de fogo na residência é obrigatória e quase nunca aparece no registro. A ausência dela é a falha mais comum destes atendimentos.

Capacidade de construir segurança

É o elemento que os outros quatro não mostram, e o que mais muda a conduta.

Sustenta o plano

- comunica o que sente a alguém
- aceita que a rede seja acionada
- pactua o que fará se piorar
- consegue reduzir o acesso hoje
- tem quem permaneça com ele

Não sustenta o plano

- oculta a situação da família
- recusa a participação da rede
- não consegue pactuar nada concreto
- não colabora por psicose ou intoxicação
- tem rede que existe e não sustenta

Rede disponível não é o mesmo que supervisão possível. Pergunte o que aquela pessoa consegue fazer, e até quando.

✕ O que a matriz substitui

baixo | moderado | alto ✕ É possível construir segurança fora daqui agora?

Por que o semáforo não resolve

A categoria não diz o que fazer. Dois pacientes classificados como risco moderado podem exigir condutas opostas, e a classificação não registra nem o que sustenta a decisão nem o que precisaria mudar para invertê-la. Escalas ajudam a não esquecer perguntas e não decidem conduta.

O que a pergunta operacional entrega

Uma resposta que já é conduta, com as duas saídas explicitadas, e um registro que permite reconstruir depois por que a decisão foi aquela.

Contextos que a matriz não resolve sozinha, I

Pessoa idosa

O QUE ELEVA O RISCO AQUI

Intenção mais determinada, menos tentativas e maior letalidade por tentativa. Doença dolorosa ou incapacitante, perda de autonomia, luto recente e isolamento.

O QUE MUDA NA CONDUTA

Manejo agressivo da dor e da comorbidade. Envolvimento explícito do cuidador. Revisão do que está guardado em casa.

ERRO CLÁSSICO

Normalizar a desesperança como coisa da idade.

Adolescente

O QUE ELEVA O RISCO AQUI

Contágio e efeito de exposição. Humilhação, ruptura e exposição digital. Impulsividade própria da faixa.

O QUE MUDA NA CONDUTA

Parceria com o responsável, com o adolescente sabendo o que será dito. Dever de comunicação ao Conselho Tutelar quando couber.

ERRO CLÁSSICO

Prometer sigilo absoluto antes de saber o que será contado.

Contextos que a matriz não resolve sozinha, II

Transtorno alimentar

O QUE ELEVA O RISCO AQUI

Na anorexia nervosa, parcela relevante da mortalidade é por suicídio, e não por complicação nutricional. Desesperança e vergonha sustentadas por anos.

O QUE MUDA NA CONDUTA

Perguntar sobre ideação em uma consulta que tende a girar só em torno de peso e de exame laboratorial.

ERRO CLÁSSICO

Reduzir a avaliação ao risco clínico nutricional.

Crise psicossocial

O QUE ELEVA O RISCO AQUI

Perda, violência, humilhação, problema jurídico ou financeiro, sem transtorno estabelecido. Risco real e frequentemente transitório.

O QUE MUDA NA CONDUTA

A conduta é companhia e restrição de acesso, com reavaliação próxima enquanto a crise passa.

ERRO CLÁSSICO

Prescrever no lugar de organizar proteção.

Restrição de acesso a meios

«Eu preciso conversar com vocês dois sobre deixar a casa mais segura nos próximos dias. Não é desconfiança. É que, quando aperta, a distância até a coisa faz diferença. O que a gente consegue tirar de casa hoje, e quem fica responsável?»

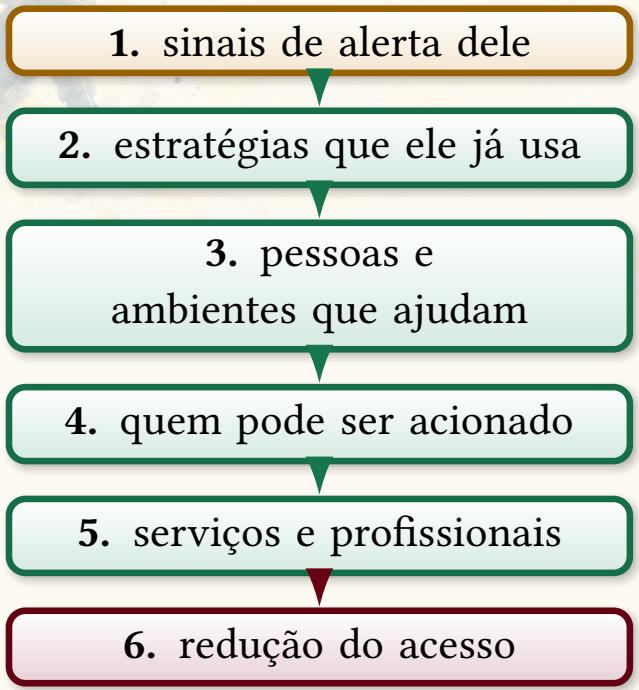
O que a conversa precisa produzir

- o que sai de casa, nomeado
- quem retira e para onde vai
- até quando fica assim
- quem confere que foi feito

O que invalida a medida

- combinar só com o paciente, e não com quem executa
- deixar sem prazo e sem responsável
- esquecer a arma de fogo
- não conferir depois

Plano de segurança



Não é contrato de não suicídio

O contrato pede uma promessa e protege o serviço. O plano descreve o que a pessoa faz, na ordem, quando o pensamento aperta, e protege a pessoa. O contrato não tem sustentação e não substitui o plano.

Escrito com ele

Nas palavras dele, no celular dele, com os nomes e os números preenchidos ainda na consulta.

Com contato de seguimento, 45% menos comportamento suicida em seis meses. Stanley et al., *JAMA Psychiatry* 2018. **[evidência]**

Tratar a crise e tratar a base

O erro mais comum desta etapa é reduzir tudo ao antidepressivo e deixar sem tratamento o que está produzindo o risco hoje.

O que tratar agora

- intoxicação em curso
- privação de sono
- dor não controlada
- agitação
- psicose
- a crise psicossocial que precipitou

O que tratar em seguida

- a condição de base, com o esquema correto para ela
- o que está mal tratado ou sem adesão
- o que mudou de tratamento há pouco
- os fatores modificáveis que a família consegue sustentar

Cada fator modificável tratado hoje é um modificador proximal a menos na formulação de amanhã.

Família do fármaco e segurança da prescrição

Segurança em superdosagem

Perfis diferem quanto ao que acontece em ingestão de toda a caixa. Isso entra na escolha do fármaco quando há suicidalidade ativa, e entra junto com eficácia, comorbidade e adesão, nunca sozinho.

Quantidade dispensada

Reduzir a quantidade entregue de uma vez é medida razoável e de baixo custo quando há acesso e pouca supervisão. **Não é critério isolado**: não substitui a restrição de acesso a outros meios, não substitui a supervisão e não serve de justificativa para alta.

Prescrever para trinta dias a quem não tem supervisão e tem ideação ativa é uma decisão, ainda que ninguém a registre como tal.

Onde existe evidência específica

Lítio

Em transtornos do humor, reduziu o número de suicídios em comparação com placebo.

Não é resgate. O efeito é de manutenção, não de plantão.

Clozapina

Em esquizofrenia e transtorno esquizoafetivo de alto risco, reduziu comportamento suicida em comparação com olanzapina, em dois anos.

Escetamina

Exemplo de redução rápida de sintoma em contextos selecionados. No Brasil, apenas a apresentação nasal tem indicação aprovada; a injetável é uso off label.

Melhora sintomática rápida não equivale a prevenção de comportamento suicida.

Cipriani et al., *BMJ* 2013 **[evidência]** Meltzer et al., InterSePT, *Arch Gen Psychiatry* 2003 **[evidência]** Parecer CFM 20/2024 **[norma]**

Janelas de vigilância

Períodos em que o risco sobe sem que o diagnóstico mude. Todos previsíveis, todos registráveis, todos ignorados com frequência.

- alta recente
- início ou troca de tratamento
- agitação e insônia
- intoxicação
- mudança abrupta
- melhora aparente

A última é a mais traiçoeira

A melhora aparente pode ser resolução do quadro e pode ser a calma de quem decidiu. As duas se parecem na sala. O que separa uma da outra é perguntar de novo, e não presumir.

Seguimento

data | local | responsável | via de contato | conduta se piorar

A expressão proibida

«Retorne se piorar» transfere ao paciente a tarefa de reconhecer a piora e de decidir sozinho o que fazer com ela. Quem está em crise é exatamente quem menos consegue fazer isso.

O que entra no lugar

«Na quinta-feira, às 14h, na unidade de saúde mental da Vila, com a enfermeira Ana. Se antes disso os pensamentos voltarem como hoje, você liga para este número, e sua irmã também tem ele.»

Contato ativo do serviço nas primeiras 48 a 72 horas, quando possível.

? O fluxo, comandado por uma pergunta

É possível construir segurança suficiente fora de um ambiente protegido neste momento?

Sim

restrição de acesso pactuada, plano de segurança escrito, rede acionada, seguimento com data e contato ativo

Não

permanência em ambiente protegido, laudo circunstanciado, modalidade definida pelo consentimento, segurança ambiental até a vaga

Em qualquer das duas saídas: reavaliar. A resposta vale para este momento, e não para a semana.

Não existe uma terceira saída chamada orientado e liberado.

Quando remover

Remover para serviço com retaguarda

- risco clínico da tentativa em curso
- intoxicação que a unidade não sustenta
- agitação ou psicose sem condições de manejo local
- necessidade de ambiente protegido sem leito na unidade

Antes de a ambulância chegar

- acompanhante definido
- segurança ambiental no intervalo
- o que já foi feito, escrito
- quem recebe do outro lado, avisado

Enquanto espera

O intervalo entre a decisão e a remoção é parte da conduta, e não uma pausa administrativa. Paciente em espera de vaga continua sob observação e continua sendo reavaliado.

O que informar à regulação

1. quem é o paciente: nome, idade, de onde está falando
2. o que aconteceu: o motivo do atendimento, em uma frase
3. estado mental atual
4. suicidalidade atual: ideação, intenção, plano, acesso
5. comportamentos recentes e o que mudou nas últimas horas
6. intoxicação, agitação ou psicose
7. condutas já realizadas neste atendimento
8. por que o ambiente atual não é suficiente

A oitava é a que decide a vaga. Diga-a nesta ordem e não começe por ela.

As três modalidades de internação

	Voluntária	Involuntária	Compulsória
quem solicita	o próprio usuário	terceiro	decisão judicial
quem autoriza	médico com CRM	médico com CRM	o juíz determina
qual documento	termo assinado na admissão	laudo e formulário	decisão judicial
comunica a quem	não se aplica	Ministério Público Estadual	conforme a decisão
em que prazo	não se aplica	72 horas, pelo responsável técnico	conforme a decisão
como termina	a pedido do usuário	a pedido do familiar ou do especialista responsável	por decisão judicial

Vale para as três

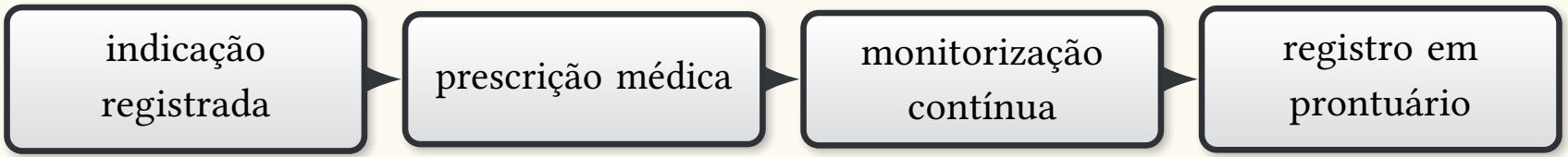
Toda internação exige **laudo circunstanciado**, a comunicação ao Ministério Público **se repete na alta**, e a **compulsória é judicial, não é a via da urgência**.

Lei 10.216/2001, arts. 6 a 9; Portaria GM/MS 2.391/2002; Resolução CFM 2.057/2013. **[norma]**

Contenção

Medida excepcional de segurança

A contenção é admissível quando é o meio mais adequado para prevenir dano imediato ou iminente. Não é punição, não é rotina de admissão e não substitui vigilância.



Reavaliação

Contenção tem início, tem revisão em intervalo curto e tem fim escrito. Contenção sem hora de término no prontuário é contenção indefinida.

Resolução CFM 2.057/2013, art. 16. **[norma]**

Sigilo

Sigilo não é silêncio absoluto

Diante de risco relevante à vida, a comunicação a quem pode proteger é legítima. Ela é **proporcional à necessidade de proteção**: diz o necessário, a quem pode agir, e não mais do que isso.

Como se faz

- buscar o consentimento primeiro, e insistir nele
- dizer ao paciente o que será dito e a quem
- informar o necessário para proteger, não o conteúdo inteiro
- registrar a justificativa

Deveres específicos

- criança e adolescente: responsável e Conselho Tutelar quando couber
- pessoa idosa em situação de violência ou negligência: proteção devida
- nunca prometer sigilo absoluto antes de saber o que será contado

Notificação de violência autoprovocada

A obrigação

Casos suspeitos ou confirmados de violência autoprovocada são de notificação compulsória pelos estabelecimentos de saúde, públicos e privados, às autoridades sanitárias. A notificação é sigilosa.

O que é evento notificável

- tentativa de suicídio
- automutilação, com ou sem ideação
- suicídio consumado

Ideação isolada não é, por si, evento notificável.

Como se faz

- Ficha de Notificação de Violência Interpessoal/Autoprovocada
- lançamento no SINAN
- tentativa de suicídio é de notificação **imediata, em até 24 horas**

Notificar não é denunciar.

Lei 13.819/2019, art. 6; Portaria GM/MS 1.061/2020, item 48. **[norma]**

Registro clínico

Função clínica

Um bom registro permite que outra pessoa, no próximo plantão, reconstrua a decisão clínica e saiba o que já foi tentado, o que foi combinado e com quem.

Função médico-legal

O mesmo registro é o que sustenta a conduta em eventual questionamento. Não se escreve para o processo; escreve-se bem, e isso serve para os dois.

1. o que foi identificado, com as falas que importam
2. a formulação construída, e não a categoria
3. por que a disposição escolhida, e não a outra
4. as medidas concretas organizadas, e quem participou
5. quando, onde e com quem será o seguimento

Continuidade

A alta não encerra o risco. Ela transfere o cuidado para outro contexto.

O período mais delicado

Os dias que seguem uma alta ou uma passagem pela urgência estão entre as janelas de vigilância. É quando o serviço presume que o caso se resolveu e o paciente presume que incomodou.

O que sustenta a transferência

- destino com nome, endereço e data
- alguém avisado do outro lado
- contato ativo nas primeiras 48 a 72 horas
- a família sabendo o que fazer, e não só o que evitar

O algoritmo

1. **Pergunte.** Use a frase de transição, sem rodeio.
2. **Caracterize.** Frequência, duração, intrusividade, capacidade de afastar, intenção, plano, preparação, acesso.
3. **Identifique o que mudou.** Últimas horas e últimos dias.
4. **Formule.** Vulnerabilidades, modificadores, suicidalidade, acesso, capacidade de construir segurança.
5. **Decida o ambiente.** É possível construir segurança fora daqui agora?
6. **Construa segurança.** Restrição de acesso pactuada e plano escrito com ele.
7. **Defina continuidade.** Data, local, responsável, via de contato, conduta se piorar.

⚠ Frases que não encerram uma decisão clínica

O que se diz	O que ficou sem resposta
«negou intenção»	negou quando, em que estado, e o que foi perguntado antes
«tem fator protetor»	o mesmo fator estava lá na semana passada
«é borderline»	o diagnóstico não informa o que aconteceu anteontem de madrugada
«está alcoolizado»	então reavalie sóbrio, não deixe de avaliar
«tem depressão»	metade da turma tem o mesmo diagnóstico no dossiê ao lado
«a escala deu risco baixo»	a escala não decide conduta
«prometeu que não fará nada»	promessa não é plano de segurança
«parece melhor agora»	melhora aparente é janela de vigilância

O erro transversal é sempre o mesmo: transformar dado isolado em decisão.

O desafio

Grupo 1 depressão maior	**Grupo 2** depressão maior	**Grupo 3** episódio misto
Grupo 4 borderline	**Grupo 5** intoxicação	**Grupo 6** psicose

A tarefa não é classificar

Ninguém vai dizer se o paciente é de risco baixo, moderado ou alto. Vocês vão dizer qual é a formulação do caso e o que fariam agora, com nome, prazo e responsável.

Todos leem todos

Os seis dossiês estão no caderno do estudante. A plenária é por pares de casos, e ninguém apresenta o próprio caso na defesa.

O produto

1. suicidalidade atual — *até 4 linhas*
2. modificadores relevantes agora — *até 4 linhas*
3. segurança e suporte disponíveis — *até 3 linhas*
4. conduta imediata — *até 5 linhas*
5. continuidade do cuidado — *até 4 linhas*
6. que informação ainda falta — *até 3 linhas*
7. conclusão tentadora que os dados não permitem — *até 2 linhas*

Pergunta da defesa: qual é a formulação de vocês e o que fariam agora?

Nenhuma decisão vale apenas por diagnóstico, por fator de risco ou por resultado de escala.